



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : دربه صلاح علي حسن

العنوان : -----

الحي / المدينة : الوراق

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

رقم البطاقة : 27004092100887 رقم التليفون : 01019325506

العمر (تاريخ الميلاد) : 09-04-1970 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه : (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

قسم العلاج :
الأورام

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر والحوض
بالصبغة [11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني : الوظيفة : ----- : التوقيع : (-----)

الاسم : د/ندى حسن : الوظيفة : ----- : التوقيع : (-----)

الاسم : د/نرمين رمضان : الوظيفة : ----- : التوقيع : (-----)

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : -----

قسم : -----

جهة العلاج : -----

نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دريه صلاح علي حسن National ID: 27004092100887	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT Chest & abdomen and pelvis
--

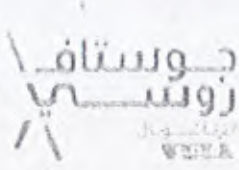
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين


 دولة الكويت
 وزارة الداخلية
 صلاح علي حسن
 رئيس النادي من الاسكن
 الوراق - الجزيرة
 ١٩٧٠/٠٩
 ٢٧٠٠٤٠٩٢١٠٠٨٨٧
 KU8082787


 ٢٠٢٤/١٠
 ٢٧٠٠٤٠٩٢١٠٠٨٨٧
 ربة منزل
 انتق
 محمد محمد كامل فرج
 البطاقة سارية حتى ٢٧/١٠/٢٧
 متروية


١١٤٥٥٨٠٨٤

DM5
جوتن في ربة منزل



مبادرة رئيس الجمهورية
لدم صحة المرأة المصرية

السلطة المصرية
للطب
مصر

MDT FORM 26/6/2025 G

Name	د. محمد عبد الله	MRN	21731009
Age	55 yrs	ID	01120680802
Menopausal status	Post menarche	Phone	
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity	medically free	REASON OF MDT	Post op

Clinical Data			
BX: ILC (R+) GII	R	L	
ER: 818	PR: 818	HER 2: 0	Ki67: 10
Sonomammography:			
Mets Workup:			
S/P Rt SM + ALN (PNACT)			
T1N1			

Recommendations: - Residual Invasive Lobular Carcinoma GII nodule
- free Deep margin
- free Nipple & areola
- Positive lymph nodes (G18) with capsular inf. (not 1 perinodal foci)
- Pathological Partial response

MDT OUTCOME & PLAN - Stage ypT1, ypN2
- Post
- DCB: 3-49, DCB Class III
- A.I
- ER, PR, Her2 neg

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : الأستاذ / نريه صلاح على حسن
Patient No. : 27004092100887
Path No. : 1986/25
Sex : Female
Age : 55 Y
Referring Doc :

Request No. : 13009577
Request Date : 02/06/2025
Verification Date : 11/06/2025
Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen:

Right SM & right SLN biopsy & Axillary lymph node dissection

Gross Examination:

- Procedure: Right simple mastectomy specimen measured 25x20x6 cm with covering skin ellipse measured 23x16 cm .
- Localization: UOQ & central
- Tumor extent : Multiple greyish white granular tumour bed sites
- Size: up to 1.9x1 cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 3 cm away from deep margin and 2 cm away from the skin
- Sentinel lymph nodes number and size: Fibrofatty tissue piece measured 4 x3.5 x1 cm enclosing 3 SLNs up to 1.5 x0.5 cm ., •ALND: Fibrofatty tissue piece measured 4x4 cm, entangling 4 nodules up to 1.5x1cm
- Frozen section: Positive SLNs (1/3) with extracapsular extension

Microscopic examination:

- Histological type: Residual Invasive lobular carcinoma, multifocal (actual tumour size 1.9x1 cm) , (cellularity 10%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): Grade II (3+2+1)
- Angiolymphatic invasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive SLNs (1/3)

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 02/07/2025 09:49:24

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

SALAH, DORYA Patient ID: 10110225002440 DOB: 09-Apr-1970 Date: 06-Feb-2025
Patient Lastname: Salah
Patient Firstname: Dorya
HIS Patient ID: 10110225002440
RIS Patient ID: 365579
Date of Birth: 09/04/1970

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

===== REPORT TEXT =====

99mTc MDP Bone Scan Report (6/2/2025)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

" Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.

" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.

" Both kidneys are visualized.

Conclusion:

" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obligated
Mahmoud Akram
Mohamed Abdeltawab, MSc

===== REPORT TEXT ENDE =====

Patient Name : الأستاذة / نزيه صلاح علي حسن	Request No. : 13009577
Patient No. : 27004092100887	Request Date : 02/06/2025
Path No. : 1986/25	Verification Date : 11/06/2025
Sex : Female	Financial Category : أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 55 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

- Axillary lymph nodes : Positive (4/5)
- Total nodal count :Positive (5/8) with extracapsular extension
- Resection Margins: Free deep margin
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Right Simple Mastectomy & right SLN biopsy&ALND (post NACT):

Residual Invasive lobular carcinoma grade II, multifocal

- Free deep margin
- Free nipple and areola
- Positive Lymph nodes (5/8) with capsular infiltration & perinodal fat invasion
- Pathologic partial response (PPR)
- Stage : ypT1 , ypN2
- RCB : 3.49 , RCB class III

Signature

Dr. Walaa Ghoneim
Dr.Heba Hassan

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Printing Date : 02/07/2025 09:49:24

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / د. ديه مناج على حسن	Request No. : 13002692
Patient No. : 27004092100887	Request Date : 29/10/2024
Path No. : 4166/24	Verification Date : 13/11/2024
Sex : Female	Financial Category : فئة الدولة - ارقام دار السلام
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:

Bifocal right breast masses.

Nature of specimen:

Tru cut biopsy, collected at 28/10/2024 , 1:25 pm.

Gross examination:

Two specimens received:

- 1) Right breast retroareolar mass: Multiple greyish white tissue cores up to 1 cm , totally submitted.
- 2) Right breast 10-11 o'clock mass: Multiple greyish white and yellowish tissue cores up to 1 cm , totally submitted.

Microscopic examination:

Both cores showed:

- * Histological type: Invasive lobular carcinoma .
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+1) Grade II .
- * DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy received.
- * Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy received.

Diagnosis:

Bifocal right breast masses, tru cut biopsies:

Both cores show: Invasive lobular carcinoma, Grade II .
For further IHC (E-cadherin, ER, PR, HER2, Ki67).

Dr. Marwa Mahmoud

Dr. Esraa Magdy

Verified by :

dr.esraa magdy

Printing Date : 27/11/2024 11:15:47

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (287) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor - Building No. 287 - Nile Corniche - Miss El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name: Donoya Salah Ali Hassan	Date: 02/12/2024
Exam: C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age: 54 Year(s)
Medical ID: 4173/2024	Pat. ID: 94826

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Right breast UIQ area of parenchymal distortion.
- Few prominent right axillary level I & II lymph nodes largest measuring 1.7 x 1.2 cm.
- Mosaic attenuation of both lung fields with bilateral scattered subpleural reticular densities.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Heterogenous texture of the thyroid gland.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No definite enhancing focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.